夜勤帯に遭遇したABO抗原減弱症例を契機とした血液型判定手順の見直し

◎大前 有美[1)]、鳥居 知美[1)]、田中 典子[1)]、多賀 みゆき[1)]、藤塚 菜穂[1)]
大垣市民病院[1)]

【はじめに】白血病や骨髄異形成症候群などの血液疾患では赤血球のABO血液型抗原が一時的に減弱し、オモテ検査に影響を及ぼすことが知られている。今回、夜勤帯で白血病による抗原減弱に気付けず判定を実施し、血液型判定に影響を及ぼした一例を経験したので報告する。

【症例】60代女性、一週間前に発熱あり。4日後に体動困難となり他院に搬送。その際の検査にてHb 3.6g/dL, WBC 200,000/μL, Blast 95%,Plt 20,000/μL,LDH 1285U/Lであり、急性白血病が疑われたため精査加療目的で当院を受診。

【検査結果・経過】全自動輸血検査装置(ORTHO VISION)で実施した血液型検査にて、抗A(0), 抗B(0), 抗D(4+),Control(0),A1赤血球(0),B赤血球(3+),不規則抗体は陰性であった。夜勤帯の技師が試験管法を行ったところ、抗A(0),抗B(0),A1赤血球(1+),B赤血球(3+)となったためO型RhD陽性として血液型を確定した。翌日の日勤帯に出勤した輸血担当技師が検査結果を確認したところ追加検査が必要と判断し精査を実施した。結果は抗A1レクチン(0),抗Hレクチン(1+), 抗A吸着解離試験陽性,A型糖転移酵素活性は64倍(対照256倍),A1赤血球との間接抗グロブリン試験陰性であり抗Aは保有していなかった。追加検査の結果より疾患による抗原減弱か亜型を疑い、血液センターに検査を依頼し、血液型が確定するまではRBCはO型RhD陽性、FFP及びPCはAB型RhD陽性で対応する方針とした。血液センターの検査結果は「亜型もしくは疾患による抗原減弱の疑い」であった。貧血が進行し複数回輸血を行っており血液型の確定が困難となったが、当院受診から8ヶ月後、「A型RhD陽性」として結果が確定された。

【結語】当院では血液型判定において再検基準を設け、オモテウラ不一致の場合は輸血担当技師に連絡することになっている。しかし今回、夜勤者はウラ検査の反応のみに着目し検査を進めてしまった。オモテ検査とウラ検査を総合的に評価することの重要性を再認識し、夜勤者には判定基準及び不一致時の対応フローの周知を行った。今後も教育を継続し血液型判定の精度向上と安全な輸血医療の実践に繋げていきたい。　　連絡先—0584-81-3341（内線1171）